

TEMA 7.25 • NEFROLOGÍA

Hipertensión Arterial

PERFIL EUNACOM 1.01.1.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **Hipertensión Arterial (HTA)** es uno de los temas más relevantes y evaluados en el examen EUNACOM. En los últimos años, los criterios diagnósticos y los objetivos terapéuticos han evolucionado hacia niveles más estrictos para reducir el riesgo cardiovascular.

Diagnóstico y Clasificación de la Presión Arterial

El diagnóstico de HTA ha pasado de un punto de corte tradicional de 140/90 mmHg a uno más temprano de **130/80 mmHg** según las guías internacionales más aceptadas actualmente.

Es fundamental distinguir entre "Presión Arterial Alta" e "Hipertensión":

TABLA 7.25.1: CATEGORÍA VS SISTÓLICA (MMHG)

CATEGORÍA	SISTÓLICA (MMHG)	DIASTÓLICA (MMHG)
Normal	< 120	y < 80
Presión Arterial Alta	120 - 129	y < 80
HTA Etapa 1	130 - 139	o 80 - 89
HTA Etapa 2	≥ 140	o ≥ 90

NOTA CLÍNICA

La "Presión Arterial Alta" (120-129/<80) no aumenta el riesgo cardiovascular de forma inmediata como la HTA, pero sí predice un riesgo elevado de desarrollar hipertensión clínica a corto plazo.

Métodos Diagnósticos

Existen tres formas principales de confirmar el diagnóstico:

- **Perfil de Presión Arterial:** Consiste en realizar al menos **3 tomas** de presión en días distintos, realizadas por personal capacitado.
- **Toma única (en casos graves):** Se puede diagnosticar con una sola medición si:
 - La presión es **≥ 180/120 mmHg**.
 - La presión es **≥ 160/100 mmHg** y existe daño a órgano blanco (ej. nefropatía o retinopatía).
- **Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA/Holter):** Es el **estándar de oro** por ser más sensible y específico. Es obligatorio ante sospecha de "hipertensión de delantal blanco".

TABLA 7.25.2: CRITERIO MAPA VS PUNTO DE CORTE (MMHG)

CRITERIO MAPA	PUNTO DE CORTE (MMHG)
Promedio Diurno	≥ 130 / 80
Promedio Nocturno	≥ 110 / 65
Promedio 24 horas	≥ 125 / 75

Objetivos del Tratamiento

El objetivo es reducir la morbimortalidad cardiovascular. Aunque existe debate, el consenso actual es:

Población General: Bajo 140/90 mmHg (objetivo clásico) o idealmente bajo 130/80 mmHg. **Alto Riesgo Cardiovascular:** Bajo **130/80 mmHg** de forma mandatoria. Incluye pacientes con **Diabetes mellitus tipo 2**, **Insuficiencia Renal Crónica** o enfermedad coronaria establecida. **Adultos Mayores (>75 años):** Se acepta un rango más flexible entre 140-150/90 mmHg, aunque si el paciente lo tolera, se prefiere buscar el <130/80 mmHg.

Pilares del Tratamiento Farmacológico

El manejo clínico se basa en cambios en el estilo de vida (dieta hiposódica, ejercicio, cese del tabaco) y fármacos antihipertensivos.

- **Inicio precoz:** Actualmente se recomienda iniciar fármacos desde el momento del diagnóstico, sin esperar meses solo con cambios de estilo de vida.
- **Terapia combinada:** Se recomienda iniciar con **dos fármacos** de distintas familias desde el inicio. Esto es obligatorio si la presión inicial es **≥ 150/100 mmHg**.
- **Elección del fármaco:** La eficacia es similar entre las familias principales (IECA, ARA II, Calcioantagonistas, Tiazidas). La elección depende de las comorbilidades y contraindicaciones del paciente.
- **Ajuste y seguimiento:** El tratamiento se ajusta habitualmente cada 3 meses, aunque al inicio los controles pueden ser más frecuentes (mensuales) hasta lograr la meta.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Hipertensión Resistente o Refractaria: Se define cuando el paciente no logra metas a pesar de usar **3 fármacos** a dosis plenas (uno de ellos debe ser un diurético). En este caso, el paso a seguir es agregar **Espironolactona** y buscar activamente causas de **Hipertensión arterial secundaria**.

Complicaciones y Daño a Órgano Blanco

La HTA crónica y no controlada genera daños estructurales y funcionales en diversos sistemas:

1. Nefropatía Hipertensiva

Se manifiesta inicialmente como proteinuria. El manejo de elección incluye el uso de **IECA** (ej. Enalapril) o **ARA II** (ej. Losartán) por su efecto nefroprotector.

2. Retinopatía Hipertensiva

Marcador visual del daño vascular sistémico. Se caracteriza por: Estrechamiento de cruces arteriovenosos. Hilos de plata o hilos de cobre (fibrosis de los vasos). Microhemorragias en llama. Exudados algodonosos (microinfartos retinianos).

3. Cardiopatía Hipertensiva

NOTA CLÍNICA

La sobrecarga de presión genera una **hipertrofia ventricular izquierda de tipo concéntrica**, lo que lleva inicialmente a una **disfunción diastólica** (dificultad para el llenado ventricular).

El control estricto de la presión es vital para prevenir la progresión a **Insuficiencia cardíaca** con fracción de eyección preservada o reducida.

4. Enfermedad Cerebrovascular

La HTA es el factor de riesgo más importante para: **ACV Isquémico:** A menudo mediado por la aparición de **Fibrilación auricular** secundaria a la cardiopatía hipertensiva. **ACV Hemorrágico:** Por ruptura de vasos penetrantes dañados. **ACV Lacunar:** Por lipohialinosis de pequeñas arterias cerebrales.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca inicie tratamiento antihipertensivo agresivo en un paciente con sospecha de ACV agudo en el servicio de urgencias sin seguir el protocolo específico de manejo de crisis hipertensiva en ACV, ya que bajar la presión bruscamente puede empeorar la zona de penumbra isquémica.

Resumen de Manejo

Diagnóstico: **≥ 130/80 mmHg** (MAPA o perfil). **Meta:** < 130/80 mmHg (especialmente en diabéticos y renales). **Inicio:** Estilo de

vida + Fármacos (idealmente 2 desde el inicio). **Resistente:** Agregar Espironolactona y descartar causas secundarias.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 50 años, sin antecedentes, con perfil de presión arterial promedio de 138/88 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hipertensión Arterial. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Punto de corte actual de HTA: mayor o igual a 130/80 mmHg; etapa 2 desde 140/90
- Holter de PA (MAPA) es el mejor examen diagnóstico; obligatorio si se sospecha HTA del delantal blanco
- Objetivo en diabéticos/IRC/alto riesgo CV: menor a 130/80; en otros es discutible entre 130/80 y 140/90
- Iniciar fármacos desde el diagnóstico; idealmente 2 fármacos; obligatorio 2 si PA mayor o igual a 150/100
- HTA refractaria (no responde a 3 fármacos): agregar espironolactona + buscar causa secundaria
- HTA es el factor de riesgo más importante para ACV isquémico, hemorrágico y lacunar
- Todos los antihipertensivos tienen eficacia similar; la elección depende de comorbilidades y efectos adversos

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPERTENSIÓN ARTERIAL)

PREGUNTA 1

Hombre de 50 años, sin antecedentes, con perfil de presión arterial promedio de 138/88 mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A) Presión arterial normal
- B) Presión arterial alta
- C) Hipertensión arterial etapa 1
- D) Hipertensión arterial etapa 2
- E) Hipertensión del delantal blanco

PREGUNTA 2

Paciente hipertenso en tratamiento con enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida a dosis adecuadas. Persiste con PA de 155/95 mmHg. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Duplicar la dosis de enalapril
- B) Agregar espironolactona y buscar causa secundaria
- C) Cambiar amlodipino por atenolol
- D) Agregar losartán
- E) Solicitar Holter de PA

PREGUNTA 3

Mujer de 60 años diabética con PA promedio de 132/82 mmHg en tratamiento con losartán 50 mg/día. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Mantener tratamiento actual
- B) Agregar un segundo fármaco
- C) Solo reforzar cambios en estilo de vida
- D) Solicitar MAPA
- E) Cambiar a enalapril

RESUMEN: HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Clase sobre diagnóstico, objetivos y pilares del tratamiento de la hipertensión arterial. El punto de corte actual es mayor o igual a 130/80 mmHg (etapa 1); mayor o igual a 140/90 es etapa 2. La presión arterial entre 120-129 con diastólica bajo 80 se considera presión arterial alta (no hipertensión). El diagnóstico se hace con perfil de presión arterial (3 tomas en días distintos) o Holter de PA (MAPA, más sensible y específico). El Holter es obligatorio ante sospecha de hipertensión del delantal blanco. El objetivo de PA es discutible: en diabéticos, IRC o alto riesgo cardiovascular, bajo 130/80 sin duda; en otros, entre 130/80 y 140/90. Se recomienda iniciar fármacos desde el diagnóstico, idealmente con dos fármacos; obligatorio con dos si PA mayor o igual a 150/100. Si no responde a tres fármacos (HTA refractaria): agregar espironolactona y buscar causa secundaria. Las complicaciones incluyen nefropatía, retinopatía, cardiopatía hipertensiva, ACV e infarto.